

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: GABRIEL FELIPE DA FONSECA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 14-12-2024

Idade: 38 anos

Peso: 123 kg

Altura: 1,80 m

Médico Solicitante: DRA.PRISCILA LEITE DA SILVEIRA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 14/12/2024 21:03 e finalizado às 15/12/2024 05:45.

A latência para início do sono foi de **26,0** min e a latência para o sono REM de **207,5** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 416,0 min, com eficiência do sono de **80,1** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **4,9** % de estágio N1, **59,0** % de estágio N2, **10,7** % de estágio N3 e **25,4** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 77,2 min. Ocorreram 128 despertares, sendo o índice de **14,7 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 631, sendo 143 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 488 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **91,0 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 90,4 e o IDR durante o sono NREM foi de 91,2. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 91,0 (nº/h), sendo 20,6 apneia/h e 70,4 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 93%, a **média** de 92% e a **mínima** de 75%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 39,9 (nº/h), sendo que em REM foi de 60,3 (nº/h) e em NREM foi de 44,6 (nº/h). Permaneceu 3,5 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório **(91,0 n°/h)** acentuadamente elevado predominando os eventos respiratórios obstrutivos (VN= até 5 n°/h);
2. Presença de dessaturação da oxi-hemoglobina associado aos eventos respiratórios anormais;
3. Latência para o início do sono normal diminuída **(26,0 min)** (VN= até 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM **(207,5 min)** (VN= 70 a 120 min)
5. Eficiência do sono diminuída **(80,1 %)** (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares normal **14,7 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal **(4,9 %)** (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 **(59,0 %)** (VN= 45% a 55%);
9. Diminuição do percentual do estágio N3 ondas delta **(10,7 %)** (VN= 13% a 23%);
10. Aumento do percentual do estágio REM **(25,4 %)** (VN= 20% a 25%).
11. Ronco constante verificado via sensor de ronco durante a leitura do exame;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

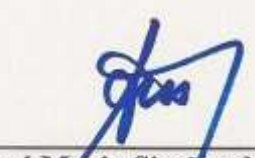
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.



Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

PROCEDIMENTO:

Exame polissonográfico noturno registrado no sistema (NeuroVirtual)®. Foram utilizados os registros de EEG: F4-M1, C4-M1, O2-M1, F3-M2, C3-M2 e O1-M2; EOG: bilateral; EMG: submentoniano; EMG: tibial bilateral; ECG: montagem D2 modificada; fluxo aéreo nasal por cânula de pressão e oronasal por termistor; esforço respiratório torácico e abdominal por pletismografia; saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) por oximetria de pulso; sensor de ronco (pela cânula nasal) e posição corporal no leito.

Parâmetros de registro recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (versão 3.0/2022)

DADOS DO PACIENTE:

Nome:	GABRIEL FELIPE DA FONSECA
ID:	0
Altura:	1,80 m
Peso:	123 kg
Sexo:	Masculino
Data de Nascimento:	15-7-1986
IMC:	37,96

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame:	21:03:34
Data do Exame:	14-12-2024
Médico Solicitante:	DRA.PRISCILA LEITE DA SILVEIRA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	14/12/2024 21:03
Data/Horário de Término:	15/12/2024 05:45
Tempo Total de Registro (TTR):	519,1
Tempo Total de Sono (TTS):	416,0
Latência para o início do sono:	26,0
Latência para o sono REM:	207,5
Tempo acordado após o adormecer:	77,2
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	80,1 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	20,5	245,5	44,5	105,5	103,5
% de TTS	4,9	59,0	10,7	25,4	19,9

Despertares

	Número	Índice (nº/h)
Total de despertares	128	14,7

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	59,3	85
NREM	63,0	97
Vigília	69,0	98

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	143	0	143	488	631	0	631
Índice	0,0	20,6	0,0	20,6	70,4	91,0	0,0	91,0
Índice em REM	0,0	13,1	0,0	13,1	77,3	90,4	0,0	90,4
Índice em NREM	0,0	23,2	0,0	23,2	68,0	91,2	0,0	91,2
Duração máx (seg)	0	64,9	0	64,9	116,0	116,0	0	116,0
Duração média (seg)	0	17,0	0	17,0	20,1	18,6	0	18,6
Índice em Supino	0	20,6	0	20,6	70,4	91,1	0	91,1
Índice em Não Supino	0	0	0	0	0	0	0	0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 91,0 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 91,0 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	92%	75%
NREM:	92%	88%
REM:	92%	75%
Vigília:	93%	88%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 92%

Total de dessaturações: 347

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	1	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

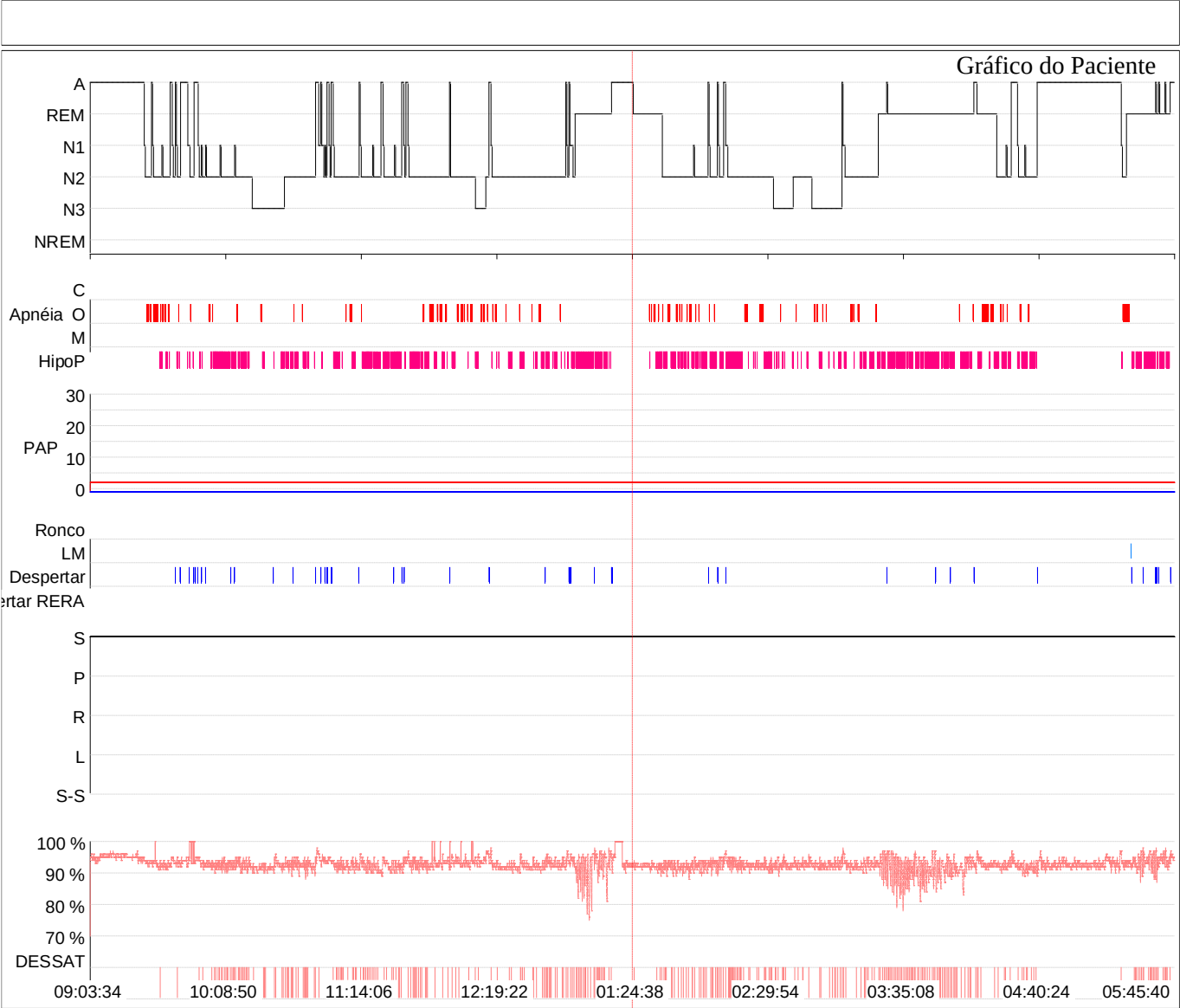
DADOS DE BRUXISMO:

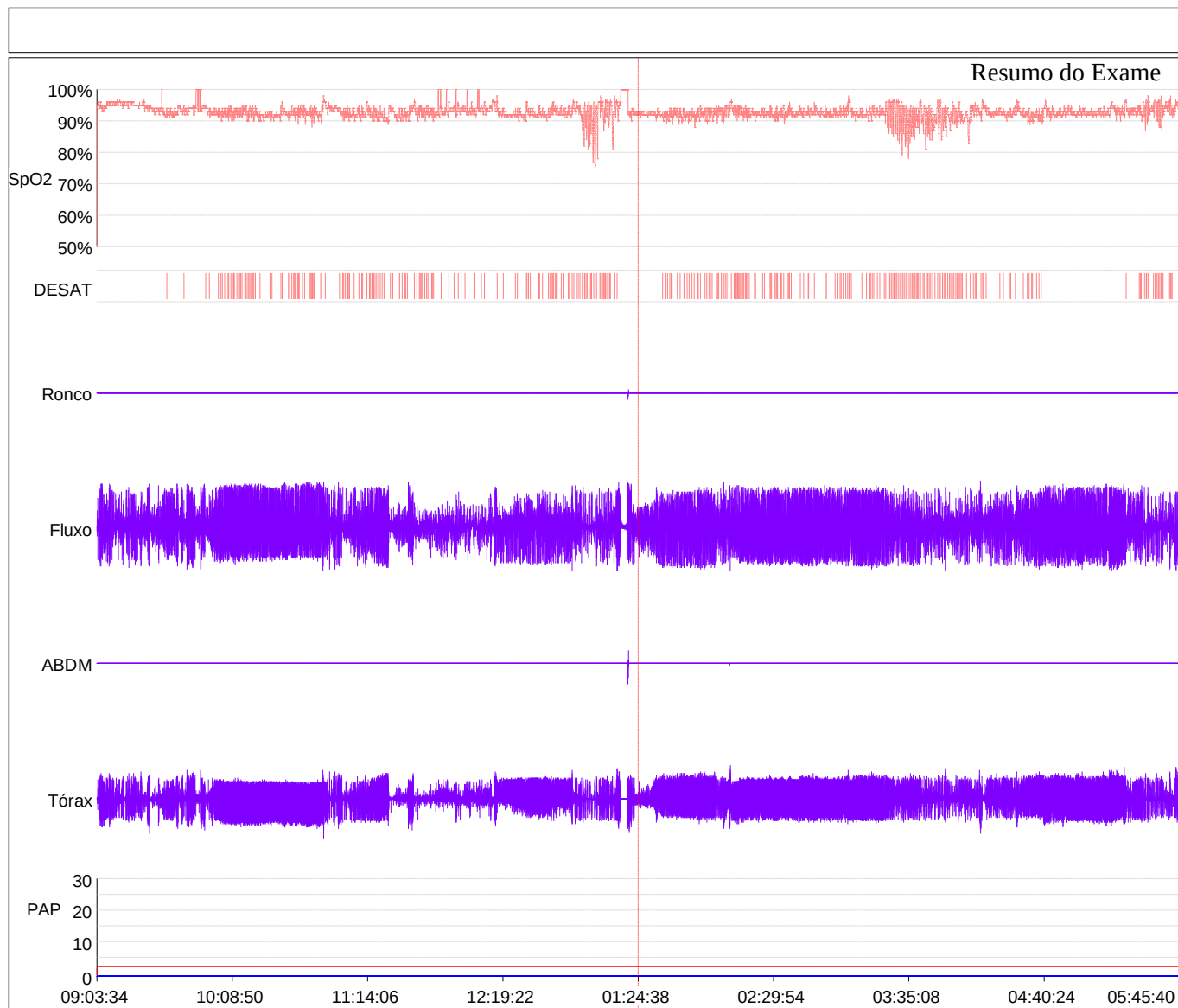
TST	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (occurrences/h)	0,0
NREM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0
REM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0
VIGÍLIA	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	0	0
SUPINO	0	23	0	136	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	0	0
SUPINO	0	120	0	352	0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	80,1 %	≥85%
Latência para o início do sono	26,0 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	207,5 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	4,9 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	59,0 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	10,7 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	25,4 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	19,9 %	5%
Índice de despertares	14,7 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	91,0 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h